

Quién puede esperar en urgencias

Un indicador donde a los pobres les va mejor, y por qué eso es una mala noticia

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE), trece rondas 2012–2025.

Son las once de la noche de un jueves. Un padre entra a urgencias con su hijo, se sienta, y espera. Dos horas después todavía está ahí.

En 2025, el **36,0 %** de las personas que acudieron a urgencias en Colombia esperó más de una hora para ser atendida por personal médico. Es el valor más alto de las trece rondas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, y está 5,6 puntos porcentuales por encima del nivel prepandémico — el promedio de 2018 y 2019, que son los dos únicos años anteriores a la pandemia comparables con el diseño muestral actual.

Ese es el dato de titular. El que me interesa es otro.

El gradiente al revés

Espera más de una hora el 49,4 % de las personas del cuarto quintil de ingreso y el 20,5 % del quintil más pobre. Casi treinta puntos de diferencia, y a favor de los pobres.

Espera más de una hora el 39,7 % en las cabeceras municipales y el 20,2 % en centros poblados y zona rural dispersa. Casi veinte puntos, y a favor del campo.

El índice de concentración —que mide en qué extremo de la distribución de ingreso se acumula un fenómeno, negativo si se carga hacia los pobres y positivo si se carga hacia los ricos— vale **+0,233** para este indicador. Es el más positivo de los quince indicadores del sistema de salud que se pueden construir con esta encuesta. Todos los demás indicadores adversos son negativos.

La lectura literal sería que la espera en urgencias es un problema de las clases medias urbanas. Voy a sostener lo contrario: **ese gradiente invertido es la mejor evidencia disponible de un problema de acceso, y precisamente donde parece que no lo hay.**

Para esperar en urgencias hay que llegar a urgencias

El indicador se calcula sobre las personas que **acudieron** al servicio. En 2025 eso son 2.653 observaciones, de una muestra total de 235.350 personas. Poco más del uno por ciento de la muestra, y ese uno por ciento no es aleatorio.

Donde no hay servicio de urgencias con médico disponible, o donde llegar exige un viaje caro y largo, una parte de los episodios simplemente no llega. Los que llegan lo hacen con cuadros más graves — porque el umbral para emprender el viaje es más alto. Y a los cuadros graves se les atiende antes.

El denominador se depura de los casos leves justamente en los territorios donde el sistema es más débil. La población que espera es la que pudo permitirse ir.

Esto tiene nombre, y es viejo

En inferencia causal se llama **condicionamiento a un colisionador**: cuando se restringe el análisis a una variable que es consecuencia común de dos causas, se induce entre esas causas una asociación que no existe en la población. Aquí la variable de restricción es «acudió a urgencias», y dos de sus causas son la gravedad del episodio y la accesibilidad del servicio.

En epidemiología se conoce desde 1946 como **sesgo de Berkson**, por el estadístico de la Clínica Mayo que lo describió al notar que las asociaciones entre enfermedades observadas en pacientes hospitalizados no se reproducían en la población general. En economía laboral es el **sesgo de selección** que le valió a James Heckman el Nobel.

Tres disciplinas, tres nombres, el mismo mecanismo. Y una regularidad incómoda en la medición de servicios de salud: **casi todos los indicadores de calidad y de oportunidad se calculan sobre quienes usaron el servicio**, porque no hay otra forma de calcularlos, y casi ninguno se publica con la advertencia correspondiente.

Un hospital que atiende a una población que llega muy tarde va a tener mejores tiempos de espera y peores desenlaces que uno cuya población llega a tiempo por cualquier molestia. Los dos números son ciertos. Solo uno de los dos hospitales está funcionando bien.

La comparación que cierra el argumento

Hay una manera de verificar esto sin salir de la misma encuesta, el mismo año y la misma muestra.

La **necesidad de atención no satisfecha** —la proporción de personas que tuvieron un problema de salud y no recibieron atención— tiene un denominador mucho más amplio: no exige haber llegado a ningún servicio, solo haberse enfermado. Y sus gradientes van exactamente al revés:

Espera en urgencias, entre quienes acudieron a urgencias:

quintil más pobre 20,5 % · cuarto quintil 49,4 % · zona rural 20,2 % · cabecera 39,7 %

Necesidad no satisfecha, entre quienes tuvieron un problema de salud:

quintil más pobre 41,0 % · quintil más rico 21,4 % · zona rural 49,1 % · cabecera 32,6 %

Mismos datos, misma metodología, mismo año. Lo único que cambia es el denominador, y con eso se invierte el signo de todos los gradientes.

Un mismo hogar rural pobre aparece del lado desfavorable en el segundo indicador y del lado favorable en el primero. La única lectura que reconcilia los dos hechos no es que a los pobres rurales los atiendan más rápido. **Es que no llegan.**

Hay una segunda explicación, y también es incómoda

El **triaje** —la clasificación por gravedad al ingreso— hace que esperar más de una hora no siempre sea una falla. Un sistema que funciona bien hace esperar al caso leve y atiende de inmediato al grave. Es lo correcto.

En las ciudades, urgencias opera en buena medida como válvula de escape de la consulta ambulatoria: quien no consigue cita acude a urgencias con un cuadro leve y espera. La proporción de esperas largas crece sin que la calidad del servicio de urgencias haya cambiado. Lo que cambió está aguas arriba, en la puerta ambulatoria.

Y hay una tercera explicación posible, más simple: los servicios urbanos atienden más volumen por unidad de capacidad, y parte de la brecha puede ser congestión genuina.

Las tres son consistentes con los datos y la encuesta no las separa, porque no registra el nivel de triaje, ni el motivo de la consulta, ni la distancia recorrida hasta el servicio. Lo que sí se puede afirmar es lo que muestra la comparación de denominadores: **el signo del gradiente depende de a quién se le pregunta, y a este indicador solo se le pregunta a quien ya pasó el filtro.**

Por qué esto importa ahora

El 12 de diciembre de 2025 el Ministerio de Salud expidió la Circular Externa 038, que crea el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera y fija estándares de referencia para la asignación de citas con especialista: tres días en medicina general, cinco en pediatría, diez en psiquiatría y cirugía general, quince en medicina interna.

Es un avance y hay que decirlo sin reservas: por primera vez el país va a tener una línea de base de tiempos de espera, y sin medición no hay gestión. Quienes impulsaron ese instrumento tienen razón en lo esencial.

El modelo mide, sin embargo, el tiempo de quien obtuvo la cita. Es la misma estructura de denominador que acabo de describir. Y de ahí se sigue una advertencia aritmética que conviene poner sobre la mesa antes de que produzca la conclusión equivocada: **si más gente desiste, la cola de los que quedan se acorta.** El indicador puede mejorar mientras el acceso empeora.

La corrección no exige rediseñar el modelo. Exige publicarlo junto al indicador de denominador amplio, que la encuesta produce cada año con representatividad departamental.

Los límites de este dato

Sin triaje no hay norma de referencia. El indicador cuenta esperas de más de una hora sin saber si estaban clínicamente justificadas. Un aumento puede reflejar peor oportunidad o mayor proporción de casos leves. Las dos cosas son informativas y son distintas.

El denominador está seleccionado, y ese límite no desaparece con ninguna corrección posible dentro de esta encuesta: haría falta identificar a quienes necesitaron urgencias y no acudieron, y la encuesta no pregunta eso.

La pregunta se refiere a la última visita, no a un promedio, así que los usuarios frecuentes están sobrerrepresentados.

La muestra es pequeña. Las estimaciones departamentales tienen intervalos muy anchos y varias regiones no alcanzan el mínimo para publicarse.

Tres cosas que se siguen de aquí

1. **No usar este indicador para priorizar territorios.** Un ranking de departamentos por espera en urgencias premiaría precisamente a los territorios sin servicio de urgencias. No es un riesgo hipotético: los indicadores de oportunidad se prestan a ese uso y los tableros los presentan ordenados de mayor a menor.
2. **El indicador correcto para priorizar es el de denominador amplio.** La necesidad de atención no satisfecha y su desglose por razón sirven para decidir dónde invertir. La espera en urgencias sirve para vigilar oportunidad donde el servicio existe. Son preguntas distintas y merecen instrumentos distintos.
3. **Dos preguntas resolverían buena parte del problema.** Registrar el nivel de triaje asignado, y preguntar si hubo algún episodio en que la persona consideró acudir a urgencias y no lo hizo, con la razón. Son dos ítems en un módulo que ya existe, y convertirían este indicador en una medida interpretable de oportunidad.

El cierre

Fui asesor en la ADRES hasta agosto de 2026 y hoy escribo desde fuera del sistema, así que invito a contrastar. Los microdatos son públicos y el cálculo es reproducible; la comparación de denominadores que sostiene esta columna se rehace en un par de horas.

Colombia tiene un problema real de oportunidad en urgencias, y el 36 % de 2025 —el máximo de trece rondas— es una señal que hay que tomarse en serio. Pero la lección de fondo es sobre cómo se lee un indicador antes de convertirlo en política.

Cuando un dato dice que a los pobres les va mejor en un servicio de salud, la primera pregunta no es qué están haciendo bien. Es **a quién no se le preguntó**.

Una cola larga no siempre es una mala noticia. Una cola corta casi nunca es una buena.

Referencias

Berkson, J. (1946). Limitations of the application of fourfold table analysis to hospital data. *Biometrics Bulletin*, 2(3), 47-53.

Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículo 6, literal e. Diario Oficial 49.427.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.

Elwert, F., & Winship, C. (2014). Endogenous selection bias: the problem of conditioning on a collider variable. *Annual Review of Sociology*, 40, 31-53.

Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153-161.

Hernán, M. A., Hernández-Díaz, S., & Robins, J. M. (2004). A structural approach to selection bias. *Epidemiology*, 15(5), 615-625.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, 12 de diciembre). *Circular Externa 038 de 2025*, Modelo de Gestión de Tiempos de Espera. Bogotá.

Pearl, J. (2009). *Causality: Models, reasoning and inference* (2.^a ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones, análisis y reflexiones que publico en este espacio son exclusivamente de mi autoría y de carácter personal. Fui Asesor de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta agosto de 2026; a la fecha de esta publicación no me desempeño en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Nada de lo aquí escrito constituye posición institucional ni representa el criterio oficial de la ADRES, del Ministerio de Salud y Protección Social, ni de ninguna otra entidad del sector.

Los contenidos se elaboran a partir de (i) información de dominio público —en particular los microdatos anonimizados que el DANE publica—, (ii) literatura académica verificable debidamente citada, y (iii) experiencia profesional acumulada a lo largo de mi trayectoria. En ningún caso divulgan información reservada, datos personales de beneficiarios, datos de operación contractual, ni elementos bajo deber de confidencialidad institucional.

Cuando discuto mecanismos de política pública, metodologías técnicas o desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hago en mi calidad de ciudadano y profesional del sector, con el ánimo de aportar al debate público informado. Las propuestas que formulo son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Quien desee la posición oficial de la ADRES sobre cualquier tema puede consultar sus canales institucionales en www.adres.gov.co.

El procesamiento que sustenta las cifras de esta columna es reproducible y está documentado en el documento de trabajo correspondiente de la serie. Esta versión es un borrador sometido a revisión externa: se agradece cualquier corrección.

Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.